DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AMAZONAS

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA SE 25

MICRORED YERBABUENA

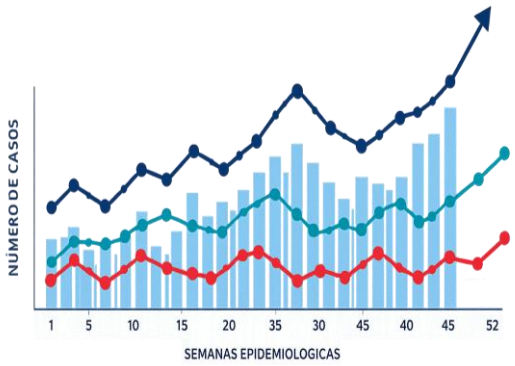
M.C. YHOJAR A. PISFIL-FARROÑAY
Responsable de Epidemiología

Tec. Enf. Roberto Ramos Gómez
Equipo Técnico de Epidemiología



Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades.

PRESENTACIÓN



La Oficina de Epidemiología de la Microred de Salud Yerbabuena pone a disposición el presente Boletín Epidemiológico, publicación técnica elaborada de manera periódica con el propósito de difundir el análisis de la situación epidemiológica de los principales eventos sujetos a vigilancia en salud pública dentro de su jurisdicción.

La información presentada en este boletín proviene de la Red Nacional de Epidemiología (RENACE), mediante la notificación semanal realizada por los establecimientos de salud que conforman la Microred de Salud Yerbabuena, complementada con información obtenida de los sistemas oficiales de vigilancia epidemiológica, investigaciones epidemiológicas de campo, vigilancia basada en eventos, salas situacionales y otras actividades desarrolladas por la Oficina de Epidemiología.

La Microred de Salud Yerbabuena, perteneciente a la Red Integrada de Salud Chachapoyas, desarrolla actividades permanentes de vigilancia epidemiológica en los distritos de La Jalca, Mariscal Castilla, San Juan de Lopecancha y un anexo del distrito de Santo Tomas, comprendiendo establecimientos de salud ubicados en zonas rurales donde el monitoreo continuo de enfermedades transmisibles, enfermedades metaxénicas, zoonosis, enfermedades inmunoprevenibles, enfermedades no transmisibles y otros eventos de importancia en salud pública constituye una herramienta fundamental para la protección de la salud de la población.

El presente boletín tiene como finalidad proporcionar información epidemiológica actualizada mediante el análisis de tendencias, distribución de casos, comportamiento de los principales daños sujetos a vigilancia e indicadores epidemiológicos, contribuyendo a la detección temprana de brotes, la identificación de riesgos y la implementación de intervenciones oportunas para la prevención y control de enfermedades.

La difusión periódica de este documento busca fortalecer el uso de la información epidemiológica como soporte para la toma de decisiones, la planificación sanitaria y la mejora continua de las acciones de vigilancia, prevención y respuesta frente a eventos que representen un riesgo para la salud pública en el ámbito de la Microred de Salud Yerbabuena.



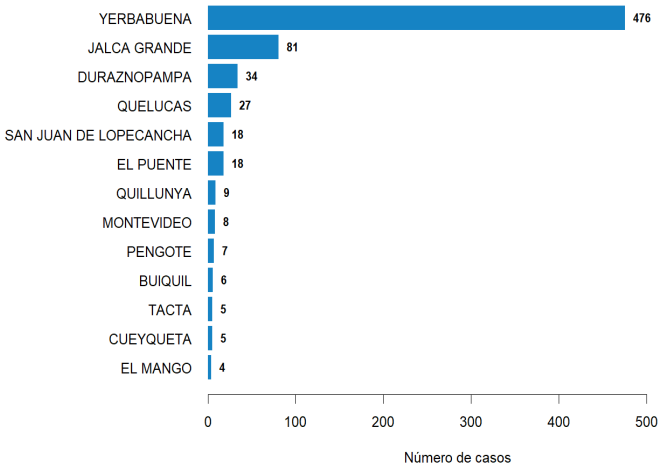
M.C. Yhojar A. Pisfil-Farroñay
Responsable de Epidemiología
Microred Yerbabuena

Situación epidemiológica de Leishmaniasis

La leishmaniasis es una enfermedad parasitaria desatendida causada por protozoarios del género *Leishmania*, transmitidos al ser humano mediante la picadura de flebótomos hembras infectados de los géneros *Lutzomyia* (Américas) y *Phlebotomus* (Viejo Mundo). La enfermedad presenta tres formas clínicas principales: cutánea, mucosa y visceral, siendo la forma cutánea la de mayor frecuencia en el continente americano y la predominante en el Perú[1].

En las Américas, la leishmaniasis constituye un importante problema de salud pública debido a su amplia distribución geográfica, su asociación con poblaciones rurales y vulnerables, y el impacto que ocasiona por las lesiones cutáneas permanentes, las secuelas funcionales y la discapacidad derivada de las formas mucosas. En el Perú, la leishmaniasis es una enfermedad endémica presente en diversas regiones de la Amazonía y de la vertiente oriental de los Andes. En la región Amazonas, la transmisión se mantiene principalmente en localidades rurales donde confluyen condiciones ecológicas favorables para el vector y reservorios naturales [3].

Gráfico 01. Microred Yerbabuena: Casos acumulados históricos de leishmaniasis, según establecimientos de salud, 2010 – 2026 (SE27).



Fuente: Sistema NOTISP. *Hasta la SE 27-2026.

La distribución histórica de los casos de leishmaniasis registrados entre 2010 y el 2026 (S.E. 27) evidencia una marcada concentración de la enfermedad en el C.S. Yerbabuena, que acumula 476 casos, seguido del C.S. Jalca Grande con 81 casos. Ambos establecimientos concentran la mayor carga histórica de casos notificados dentro de la jurisdicción de la Microred de Salud Yerbabuena. En menor magnitud se encuentran el P.S. Duraznopampa (34 casos), P.S. Queluca (27 casos), P.S. Lopecancha (18 casos) y P.S. El Puente (18 casos), mientras que establecimientos como P.S. Cueyqueta, P.S. Pengote, P.S. El Mango y P.S. Montevideo presentan una menor frecuencia acumulada de casos durante el periodo evaluado. La distribución observada sugiere la existencia de focos históricos de transmisión en el ámbito de influencia de los establecimientos con mayor carga acumulada, lo que refleja la persistencia de condiciones ecológicas y ambientales favorables para la transmisión de la enfermedad.

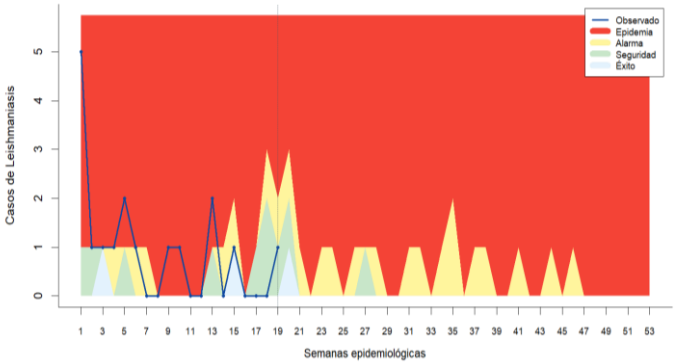
Tabla 01. Microred Yerbabuena: Número de casos por tipo de leishmaniasis y defunciones 2021* – 2026*.

AÑOS	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026
N° de Casos	17	21	24	18	16	17
IA x 100 Hab.	0.43	0.37	0.41	0.31	0.28	0.29
Defunciones	0	0	0	0	0	0
Letalidad x 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POB	3936	5690	5886	5834	5809	5787

Fuente: Sistema NOTISP. *Hasta la SE 27-2026.

Durante el periodo 2021–2026 (hasta la SE 27), la Microrred Yerbabuena notificó entre 16 y 24 casos anuales de leishmaniasis, observándose el mayor número de casos en 2023 (24 casos), seguido de una tendencia descendente en los años posteriores. La incidencia acumulada osciló entre 0,28 y 0,43 casos por 100 habitantes, registrándose el valor más alto en 2021 (0,43) y el más bajo en 2025 (0,28), lo que refleja una disminución progresiva de la carga de enfermedad en los últimos años. Hasta la SE 27 de 2026 se han confirmado 17 casos, con una incidencia de 0,29 por 100 habitantes, manteniéndose en valores similares a los observados en 2025. Durante todo el periodo analizado no se notificaron defunciones atribuibles a leishmaniasis, por lo que la letalidad se mantuvo en 0%, evidenciando un adecuado diagnóstico y manejo oportuno de los casos. En conjunto, estos resultados indican una transmisión persistente de la enfermedad en el ámbito de la microrred, aunque con una baja incidencia y sin impacto en la mortalidad, lo que resalta la importancia de mantener las acciones de vigilancia epidemiológica, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y control de los factores de riesgo en las localidades endémicas.

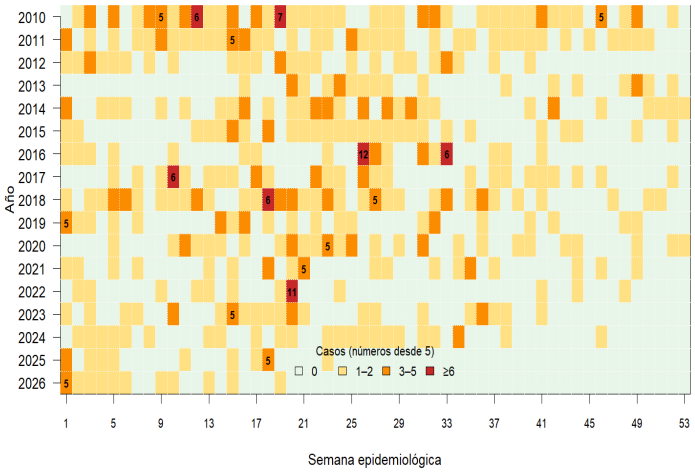
Gráfico 02. Microred Yerbabuena: Canal endémico de casos de Leishmaniasis, Año 2026*



Fuente: Sistema NOTISP. *Hasta la SE 27-2026.

El canal endémico de leishmaniasis construido con información histórica del periodo 2021–2025 mediante el método de cuartiles, muestra que durante las primeras 27 semanas epidemiológicas de 2026 la notificación se mantuvo predominantemente dentro de las zonas de éxito, seguridad y, en menor proporción, de alarma, sin superar el umbral epidémico esperado. El mayor número de casos se registró en la SE 1 (cinco casos), seguido de notificaciones aisladas de uno a dos casos en semanas posteriores, comportamiento compatible con una transmisión focal y esporádica. No se observó permanencia de las notificaciones en la zona epidémica ni incrementos consecutivos que sugieran un brote activo o una intensificación sostenida de la transmisión. En conjunto, el comportamiento epidemiológico evidencia una circulación persistente de la enfermedad dentro de los niveles históricos esperados para la microrred.

Gráfico 03. Microred Yerbabuena: Comportamiento temporal de los casos de leishmaniasis cutánea según semana epidemiológica, 2010 - 2026*



Fuente: Sistema NOTISP. *Hasta la SE 27-2026.

El mapa de calor del comportamiento temporal de la leishmaniasis cutánea evidencia una transmisión persistente en la Microrred Yerbabuena durante el periodo 2010–2026 (hasta la SE 27), con notificación de casos en la mayoría de los años evaluados. La ocurrencia de la enfermedad presenta una distribución heterogénea a lo largo de las semanas epidemiológicas, observándose predominio de semanas con uno a dos casos y episodios focales de mayor intensidad en determinados periodos. Los conglomerados de mayor magnitud se registraron en 2016 y 2022, alcanzando hasta 12 y 11 casos en una misma semana epidemiológica, respectivamente, lo que evidencia incrementos transitorios de la transmisión. En contraste, durante 2026 la notificación se ha mantenido en niveles bajos, con un máximo de cinco casos al inicio del año y ausencia de conglomerados similares a los registrados históricamente. En conjunto, el patrón observado es compatible con un comportamiento endémico de la enfermedad, caracterizado por la presencia continua de casos y aumentos esporádicos de intensidad, lo que sustenta la necesidad de mantener una vigilancia epidemiológica permanente, así como intervenciones oportunas de diagnóstico, tratamiento y control en las zonas de mayor riesgo.

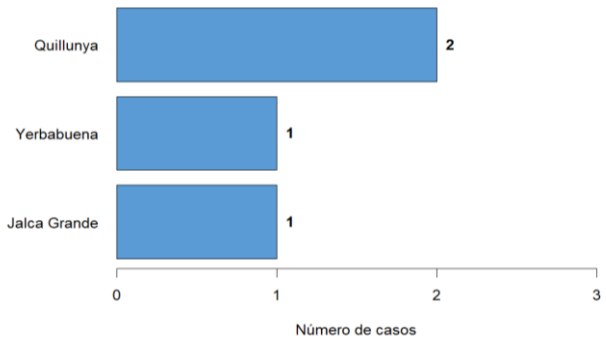
Situación epidemiológica de Enfermedad Mano-Pie-Boca

La enfermedad mano-pie-boca (EMPB) es una infección viral aguda causada principalmente por enterovirus humanos del grupo A, entre ellos los virus Coxsackie A16, Coxsackie A6 y Enterovirus A71 (EV-A71), que afecta predominantemente a lactantes y niños menores de cinco años. Clínicamente se caracteriza por fiebre, lesiones vesiculares en manos, pies y cavidad oral; sin embargo, determinados serotipos, especialmente EV-A71, pueden ocasionar complicaciones neurológicas, cardiopulmonares e incluso defunciones. La transmisión ocurre principalmente por contacto directo con secreciones respiratorias, líquido de las vesículas, heces o superficies contaminadas, favoreciendo la aparición de brotes en instituciones educativas, guarderías y comunidades con estrecha interacción entre niños. Debido a su elevada transmisibilidad y potencial de propagación, constituye un evento de importancia para la salud pública [4,5].

La vigilancia epidemiológica de la EMPB permite identificar oportunamente cambios en la tendencia

de la enfermedad, detectar conglomerados o brotes, caracterizar los grupos poblacionales afectados y orientar la implementación de medidas de prevención y control. Asimismo, facilita la búsqueda activa de casos, el fortalecimiento de las medidas de higiene, el aislamiento oportuno de los pacientes, la educación sanitaria dirigida a padres y cuidadores y la evaluación del comportamiento temporal del evento. En escenarios donde se evidencia un incremento inusual de casos o la aparición de formas graves, la vigilancia también contribuye a la confirmación etiológica mediante laboratorio y al fortalecimiento de la respuesta de los servicios de salud, reduciendo el riesgo de transmisión sostenida y de complicaciones asociadas a enterovirus con mayor virulencia [6,7].

Gráfico 04. Microred Yerbabuena: Casos acumulados de Enfermedad Mano-Pie-Boca por establecimiento, hasta la SE 27 - 2026.*



Fuente: Registros de Unidad de Vigilancia, MR. Yerbabuena.*SE27

Hasta la SE 27 (2026), se ha notificad cuatro casos de enfermedad mano-pie-boca, distribuidos en tres establecimientos de salud. El P.S. Quillunya concentró el mayor número de casos, con dos notificaciones (50% del total), seguido del C.S. Yerbabuena y el C.S. Jalca Grande, con un caso cada uno (25%, respectivamente). Los demás establecimientos de la microred no registraron casos durante el periodo evaluado.

Esta distribución evidencia una presentación focal del evento, sin afectación generalizada en el ámbito de la jurisdicción. La identificación de casos en diferentes establecimientos resalta la importancia de mantener una vigilancia epidemiológica activa, especialmente en poblaciones infantiles y en instituciones educativas, donde la transmisión puede ocurrir con rapidez.

Situación epidemiológica de las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA)

Las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) constituyen una de las principales causas de morbilidad en la población infantil y representan un importante problema de salud pública, especialmente en países de ingresos bajos y medianos. Su presentación está estrechamente relacionada con deficiencias en el acceso a agua segura, saneamiento básico e higiene, así como con factores ambientales y socioeconómicos que favorecen la transmisión de agentes infecciosos. Aunque la mayoría de los episodios son autolimitados, las EDA continúan siendo una causa importante de deshidratación, hospitalización y mortalidad en menores de cinco años [8].

En el Perú, las EDA forman parte de los eventos sujetos a vigilancia epidemiológica mediante notificación semanal, lo que permite monitorear su comportamiento temporal, detectar incrementos inusuales, identificar grupos de mayor riesgo y orientar oportunamente las intervenciones de prevención y control. El análisis continuo de esta información constituye una herramienta fundamental para evaluar la situación epidemiológica y fortalecer la toma de decisiones en los diferentes niveles del sistema de salud [9].

Tabla 02. Microred Yerbabuena: Casos acumulados por establecimientos y grupo etario, 2022 – 2026*

Grupo etario	2011–2025	2026*	% 2026
<1 año	562	11	6.011%
1–4 años	2160	48	26.230%
5 años	3492	0	0.000%
5–11 años	148	27	14.754%
12–17 años	55	14	7.650%
18–29 años	78	14	7.650%
30–59 años	157	42	22.951%
≥60 años	102	27	14.754%
Total	**6754**	**183**	**100.000%**

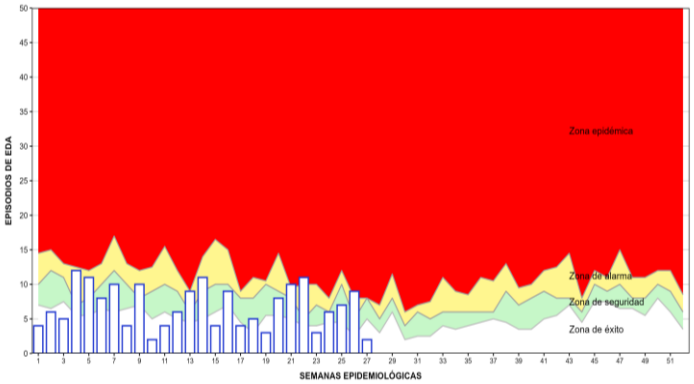
** Información del 2026 acumulada hasta la SE 27. El porcentaje corresponde a la distribución de episodios del año 2026.*

Fuente: Sistema NOTISP.

Hasta la SE 27 (2026), la Microred Yerbabuena notificó 183 episodios de enfermedad diarreica aguda (EDA), observándose una mayor concentración en el grupo de 1 a 4 años, con 48 episodios (26,2%), seguido de la población de 30 a 59 años con 42 episodios (23,0%).

Los grupos de 5 a 11 años y de 60 años a más registraron 27 episodios cada uno (14,8%), mientras que los menores de un año representaron el 6,0% del total notificado. En el periodo histórico 2021–2025, el mayor número acumulado de episodios correspondió a los niños de 5 años (3 492 episodios), seguido del grupo de 1 a 4 años (2 160 episodios), lo que evidencia una elevada carga de enfermedad en la población infantil. Durante 2026 no se notificaron episodios en el grupo de 5 años, observándose un desplazamiento de la mayor frecuencia hacia otros grupos etarios.

Gráfico 05. Microred Yerbabuena: Canal endémico de EDA acuosa por SE, 2026*



Fuente: Sistema NOTISP. *Hasta la SE 27-2026.

El canal endémico de enfermedad diarreica aguda (EDA) acuosa, construido con información histórica mediante el método de cuartiles, muestra que durante las primeras 27 semanas epidemiológicas de 2026 la notificación se mantuvo predominantemente dentro de las zonas de seguridad y alarma, sin superar el umbral epidémico esperado. Las mayores frecuencias se registraron entre las semanas 5 y 27, alcanzando valores cercanos a 10–11 episodios semanales, seguidas de una disminución progresiva hacia el final del periodo evaluado. No se evidenció permanencia de las notificaciones en la zona epidémica ni un incremento sostenido que sugiera la ocurrencia de un brote. En conjunto, el comportamiento observado es compatible con el patrón histórico esperado para la microrred. No obstante, debido a la naturaleza estacional y al potencial de transmisión de las enfermedades diarreicas, resulta indispensable mantener la vigilancia epidemiológica continua, fortalecer la investigación de incrementos inusuales y reforzar las intervenciones de prevención relacionadas con el acceso a agua segura, saneamiento básico, higiene de manos y vigilancia de la calidad de los alimentos.

Tabla 03. Microred Yerbabuena: Número de episodios, tasa y defunciones por EDA, 2021 – 2026*

Años	2021	2022	2023	2024	2025	2026*
N° de episodios	228	373	545	535	396	183
Tasa × 100 hab.	3.94	6.445	9.418	9.245	6.843	3.162
Defunciones	0	0	0	0	0	0

** Información del 2026 acumulada hasta la SE 27. Tasas calculadas por cada 100 habitantes, utilizando la población total 2026 como denominador fijo. Los años anteriores se presentan completos.*

Fuente: Sistema NOTISP. *Hasta la SE 27-2026.

Durante el periodo 2021–2026 (hasta la SE 27), la Microrred Yerbabuena registró un comportamiento variable de las enfermedades diarreicas agudas (EDA), observándose un incremento progresivo de los episodios entre 2021 y 2023, año en el que se alcanzó el mayor número de notificaciones (545 episodios) y la tasa más alta (9,42 por 100 habitantes). En 2024 la carga de enfermedad se mantuvo elevada, con 535 episodios (9,25 por 100 habitantes), seguida de una disminución en 2025 (396 episodios) y en 2026, cuando hasta la SE 27 se notificaron 183 episodios, con una tasa acumulada de 3,16 por 100 habitantes. Esta reducción sugiere un menor nivel de transmisión respecto a los años previos, aunque la interpretación debe considerar que la información de 2026 corresponde a un periodo aún no concluido. Durante todo el periodo analizado no se registraron defunciones asociadas a EDA, lo que evidencia una letalidad de 0%.

Situación Epidemiológica de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), Neumonías, SOB/ASMA

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) constituyen uno de los eventos de mayor importancia en la vigilancia epidemiológica debido a su elevada frecuencia, impacto en la morbilidad y potencial para ocasionar complicaciones como neumonía, especialmente en niños menores de cinco años, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Su comportamiento está influenciado por factores estacionales, condiciones climáticas, contaminación ambiental, hacinamiento y circulación de virus y bacterias respiratorias, por lo que el monitoreo continuo resulta fundamental para identificar oportunamente cambios en su tendencia epidemiológica [10].

En el Perú, las IRA, neumonías y el síndrome obstructivo bronquial/asma (SOB/ASMA) forman parte de la vigilancia epidemiológica rutinaria mediante notificación semanal, permitiendo evaluar su comportamiento temporal, detectar incrementos inusuales y orientar las

intervenciones de prevención y control. El análisis sistemático de estos eventos facilita la identificación de grupos de mayor riesgo, la evaluación del impacto de las medidas de salud pública y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los servicios de salud frente a enfermedades respiratorias de importancia epidemiológica [11].

Tabla 04. Microred Yerbabuena: Episodios y razón por IRA, 2021 - 2026*.

Años	2021	2022	2023	2024	2025	2026*
N° de episodios	152	433	421	402	383	248
Tasa × 100 hab.	32.48	92.52	89.96	85.9	81.84	52.99

** Información acumulada hasta la SE 27 para todos los años. Tasas calculadas por cada 100 habitantes menores de 5 años, utilizando la población 2026 como denominador fijo para todo el periodo.*

Fuente: Sistema NOTISP. *Hasta la SE 27-2026.

Durante el periodo 2021–2026 (SE 27), las infecciones respiratorias agudas (IRA) en menores de cinco años mostraron una elevada carga de enfermedad en la Microrred Yerbabuena, registrándose el mayor número de episodios en 2022, con 433 casos y una tasa de 92,52 por 100 habitantes menores de cinco años. A partir de ese año se observa una tendencia descendente sostenida, con 421 episodios en 2023, 402 en 2024 y 383 en 2025, reflejada también en la reducción progresiva de las tasas de incidencia. Hasta la SE 27 de 2026 se notificaron 248 episodios, con una tasa acumulada de 52,99 por 100 habitantes menores de cinco años, inferior a la registrada en el mismo periodo de los años precedentes. Este comportamiento sugiere una disminución de la carga de IRA en la población infantil; sin embargo, debido a que la información de 2026 corresponde a un periodo parcialmente transcurrido, es necesario mantener el seguimiento durante las semanas restantes del año.

Tabla 05. Microred Yerbabuena: Distribución de episodios de IRA en menores de 5 años, según grupo etario. Acumulado 2010-2025, 2026*.

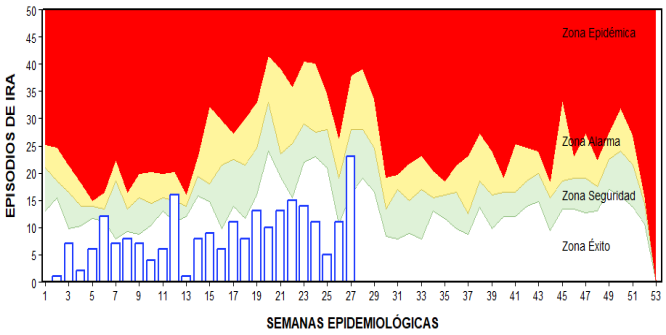
Grupo etario	2010–2025	2026*	% 2026
<2 meses	469	2	0.8065%
2–11 meses	3753	49	19.7581%
1–4 años	12890	197	79.4355%
Total	**17112**	**248**	**100.0000%**

** Información del 2026 acumulada hasta la SE 27. El porcentaje corresponde a la distribución de episodios del año 2026.*

Fuente: Sistema NOTISP.

La distribución de los episodios de IRA en menores de cinco años evidencia que la mayor carga de enfermedad se concentra consistentemente en el grupo de 1 a 4 años. Durante el periodo histórico 2010–2025 se notificaron 17 112 episodios, de los cuales 12 890 (75,3%) correspondieron a este grupo etario, seguido de los niños de 2 a 11 meses con 3 753 episodios (21,9%) y los menores de dos meses con 469 episodios (2,7%). Hasta la SE 27 (2026) se registraron 248 episodios, manteniéndose el mismo patrón epidemiológico: el 79,4% (197 casos) ocurrió en niños de 1 a 4 años, el 19,8% (49 casos) en lactantes de 2 a 11 meses y solo el 0,8% (2 casos) en menores de dos meses. Estos hallazgos confirman que los niños de 1 a 4 años constituyen el grupo con mayor riesgo de presentar IRA en la microrred, por lo que las intervenciones preventivas, la vigilancia epidemiológica, la vacunación, la educación a cuidadores y la detección oportuna de signos de alarma deben priorizarse en esta población para reducir la morbilidad y prevenir complicaciones respiratorias. infancia.

Gráfico 06. Microred Yerbabuena: Canal endémico de episodios de IRA en menores de 5 años. año 2026*



Fuente: Sistema NOTISP. *Hasta la SE 27-2026.

El canal endémico de infecciones respiratorias agudas (IRA) en menores de cinco años, construido con información histórica mediante el método de cuartiles, muestra que hasta la semana epidemiológica 27 de 2026 el comportamiento del evento se mantuvo predominantemente dentro de las zonas de éxito y seguridad, sin superar el umbral epidémico esperado. Durante las primeras semanas del año se observaron fluctuaciones propias de la estacionalidad, con un incremento progresivo de las notificaciones entre las semanas 15 y 27, alcanzando el mayor registro en la SE 27, donde los episodios ingresaron a la zona de alarma. No obstante, no se evidenció el ingreso a la zona epidémica ni una permanencia sostenida por encima de los límites esperados. Estos resultados indican que la actividad de las IRA se

mantiene dentro del comportamiento histórico de la microrred; sin embargo, el incremento observado al final del periodo evaluado justifica intensificar la vigilancia epidemiológica, fortalecer el monitoreo semanal y reforzar las acciones de prevención, diagnóstico oportuno y seguimiento de neumonías, especialmente en la población menor de cinco años, con el fin de detectar precozmente cualquier cambio en el patrón de transmisión.

Indicador de monitoreo de la notificación del sistema de vigilancia epidemiológica.

Los indicadores de monitoreo contribuyen a mejorar la información semanal para que esta sea oportuna y de calidad; consecuentemente la Microred de Yerbabuena pueda cumplir con el procesamiento y análisis de datos válidos para la toma de decisiones en la prevención y control de los daños sujetos a vigilancia en salud pública. Teniendo como criterios de calificación para los Indicadores de Monitoreo: **DEBIL, REGULAR, BUENO Y OPTIMO.**

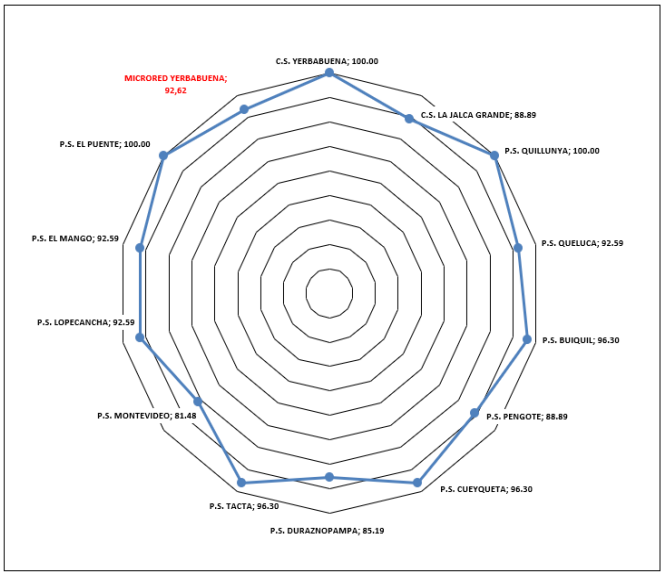
Estratos Nacionales

OPORTUNIDAD %	COBERTURA %	CALIDAD DEL DATO %	RETROALIMENTACION %	PUNJTAJE TOTAL	
1. 100	1. 100	1. 95 - 100	1. 90 - 100	**A.** 90 - 100	**OPTIMO**
2. 95 - 99.9	2. 80 - 99.9	2. 90 - 94.9	2. 80 - 89.9	**B.** 80 - 89.9	**BUENO**
3. 90 - 94.9	3. 60 - 79.9	3. 85 - 89.9	3. 70 - 79.9	**C.** 70 - 79.9	**REGULAR**
4. <90	4. <60	4. <85	4. <70	**D.** <70	**DEBIL**

Fuente: Centro Nacional de Epidemiologia, Prevencion y Control de Enfermedades - MINSA

Indicador de Oportunidad

Gráfico 07. Microred Yerbabuena: Oportunidad de notificación del año 2026*

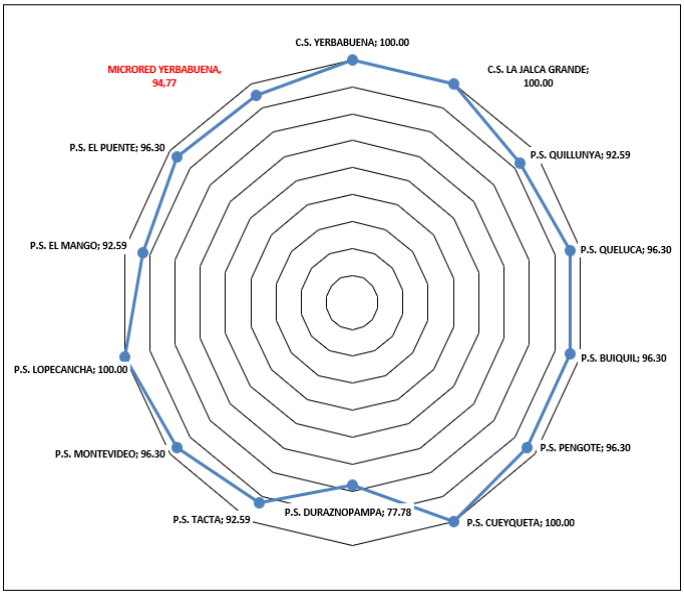


Fuente: Equipo técnico de Epidemiología Microred Yerbabuena, *Hasta la SE 25.

En los indicadores de oportunidad, a la semana epidemiológica (25) del año 2026, los establecimientos del C.S. Jalca Grande (88,89%), P.S. Pengote (88,89%), P.S. Duraznopampa (85,19%) y el P.S. Montevideo (81,48%) obtuvieron una calificación de oportunidad **BUENA.** Por otro lado, los demás establecimientos de la jurisdicción de la Microred Yerbabuena calificaron como **ÓPTIMA.**

Por lo tanto, a nivel de la Microred Yerbabuena se alcanzó un puntaje de **92.62%** calificando como **OPTIMO.**

Gráfico 08. Microred Yerbabuena: Calidad de notificación del año 2026*



Fuente: Equipo técnico de Epidemiología Microred Yerbabuena, *Hasta la SE 25.

En el indicador de calidad de datos, hasta las SE 25 del año 2026, se observa que el P.S. Duraznopampa (77,78%) presenta una calificación **REGULAR**, a diferencia de los demás establecimientos que califican dentro de los parámetros de **OPTIMO.**

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Leishmaniasis [Internet]. [citado el 3 de julio de 2026]. Disponible en: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/leishmaniasis?utm_source=
2. Manual of procedures for leishmaniases surveillance and control in the Americas. (2019). [Publications]. PAHO. https://iris.paho.org/handle/10665.2/51838
3. Organización Panamericana de la Salud. Leishmaniasis: Epidemiological Report for the Americas. No. 13. December 2024
4. Meneses MJ, Acosta A, Álvarez M. Mano-pie-boca. Archivos de Pediatría del Uruguay [Internet]. 23 de abril de 2026;97(1):e602. Disponible en: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-12492026000101602

5. Meneses MJ, Acosta A, Álvarez M. Mano-pie-boca. Archivos de Pediatría del Uruguay [Internet]. 23 de abril de 2026;97(1):e602. Disponible en: https://adp.sup.org.uy/index.php/adp/article/view/664
6. Epidemiological alert - Hand, foot, and mouth disease - 26 March 2025 [Internet]. PAHO/WHO | Pan American Health Organization. 2025. Disponible en: https://www.paho.org/en/documents/epidemiological-alert-hand-foot-and-mouth-disease-26-march-2025?utm_source=
7. CDC Perú: Situación de la enfermedad de mano, pie y boca (EMPB) en el Perú – Centro Nacional de Epidemiología Prevención y Control de Enfermedades [Internet]. 2023. Disponible en: https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/informacion-publica/prensa/cdc-peru-situacion-de-la-enfermedad-de-mano-pie-y-boca-empb-en-el-peru/
8. Diarrhoeal disease [Internet]. Who.int. [citado el 4 de julio de 2026]. Disponible en: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diarrhoeal-disease?utm_source=
9. Minsa. Norma Técnica de salud para la vigilancia epidemiológica de la enfermedad diarreica aguda (EDA) en el Perú [Internet]. Disponible en: https://www.dge.gob.pe/portal/docs/tools/eda/NTS_190-2022-MINSA-CDC-EDA.pdf
10. Minsa. Infecciones respiratorias agudas en el Perú. [Internet]. Disponible en: https://iris.paho.org/server/api/core/bitstreams/1c80b975-35eb-4b79-b64a-0654b10571af/content
11. Minsa. Directiva Sanitaria N°061 para la vigilancia epidemiológica de las Infecciones Respiratorias Agudas, 2015. [Internet]. Disponible en: https://riscuscovraem.pe/wp-content/uploads/2024/07/Directiva-vigilancia-IRA.pdf